

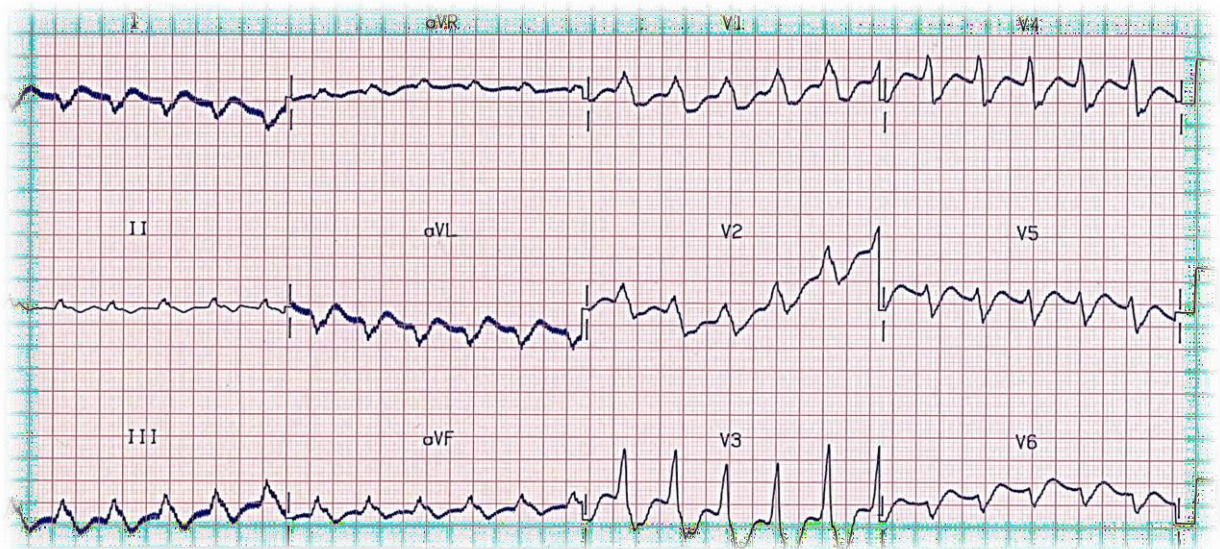
Ви лікар приймального відділення дитячої клінічної лікарні.

Каретою швидкої допомоги доставлена дитина 9-ти років зі скаргами на приступ серцебиття, що супроводжувався відчуттям дискомфорту у ділянці серця, страхом смерті та слабкістю.

Зі слов мати дитини, ЧСС під час приступу становила 180-196 уд/хв. Приступ повторюється вдруге після фізичного навантаження. Перший приступ виник рік тому. З анамнезу життя: рідко ГРВІ 3-4 рази на рік.

Ви бачите: стан дитини тяжкий. Аускультативно в легенях – везикулярне дихання. Межі відносної серцевої тупості: права – по правому краю грудини, верхня – II м/р, ліва – по середньключичній лінії. При аускультції серця – тони гучні, ритмічні, ЧСС до 190 уд/хв. Артеріальний тиск 118/70 мм рт ст. Живіт м'який, безболісний. Печінка не збільшена. Фізіологічні відправлення без особливостей.

Дані ЕКГ



Дані біохімічного обстеження крові

Тропонин I – 0,1 нг/мл (норма 0.0-0.8)

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Встановити контакт з пацієнтом та батьками/опікунами (привітатись, представитися, позначити свою роль). Коректне розташування лікар-пацієнт	Сказати Доброго дня. Я лікар педіатр.
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного обстеження дитини	Сказати Чи дасте Ви свою згоду на проведення клінічного обстеження Вашої дитини (Будемо вважати що згода отримана)
2.Збір скарг та анамнезу		

2.1	Скарги пацієнта (зі слів батьків/опікунів)	Сказати: Скільки років дитині? Очікувана відповідь: 8 років Сказати: Які скарги у дитини? Очікувана відповідь: приступ серцебиття, що супроводжувався відчуттям дискомфорту у ділянці серця, страхом смерті та слабкістю
2.2	Анамнез захворювання	Сказати: Як довго дитина хворіє? Очікувана відповідь: Приступ повторюється вдруге після фізичного навантаження. Перший приступ виник рік тому.
2.2	Анамнез життя	На які захворювання дитина хворіла? Алергія? Травми/операції? Щеплення? Спадковість?
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавички	Виконати/сказати Будемо вважати, що руки оброблені
3.2	Загальний стан.	Сказати: стан дитини тяжкий
3.3	Обстеження дихальної системи	Сказати: Перкуторно над легеньми – легенький звук. При аускультатії – везикулярне дихання
3.4	Обстеження серцево-судинної системи	Сказати: Межі відносної серцевої тупості: права – по правому краю грудни, верхня – II м/р, ліва – по середньключичній лінії. При аускультатії серця – тони гучні, ритмічні, ЧСС до 190 уд/хв. Артеріальний тиск 118/70 мм рт ст. - норма
4.Діагностика		
4.1	Визначити результат ЕКГ, артеріального тиску	Сказати: ознаки пароксизмальної шлуночкової тахікардії
4.2	Визначити результат рівня тропоніна I	Сказати: рівень тропоніна I в межах норми
4.3	Визначити провідний синдром	Сказати: аритмічний
4.4	Встановити клінічний діагноз	Сказати: Пароксизмальна шлуночкова тахікардія

5.Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення пацієнта	госпіталізація в стаціонар у відділення інтенсивної терапії, проведення синхронізованої кардіоверсії(в/в кордарон, АТФ, електрична кардіоверсія) та антиаритмічної терапії (аміодарон)
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	Сказати:дозоване фізичне навантаження, раціональне харчування, санація вогнищ хронічної інфекції
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнта/батьків/опікунів про можливі ризики та етичні аспекти	Сказати:Ви повинні знати про можливі ускладнення пароксизмальної тахікардії